Algias faciales

Dolor crónico: dolor neuropático

CONTENIDO

1. Objetivos
2. Introducción
3. Conceptualización del dolor facial
4. Epidemiología
5. Clasificación del dolor facial
6. Aspectos clínicos del dolor facial
7. Manejo diagnóstico. Pruebas complementarias
8. Terapias combinadas en el manejo del dolor facial
9. Abordaje invasivo en el tratamiento del dolor facial
10. Bibliografía y fuentes de consulta

Objetivos

- Dar a conocer los conceptos fisiopatológicos de las algias faciales.
- Mostrar al alumno las consideraciones clínicas relevantes para el diagnóstico de las algias faciales en la práctica clínica diaria.
- Establecer las bases para el manejo terapéutico de las algias faciales más comunes, diferentes herramientas y sus principales indicaciones en la práctica clínica.

Introducción

El dolor facial está caracterizado fundamentalmente por la afectación del área inervada por el nervio trigémino: la piel y la mucosa de la cara, el sistema osteomuscular de la cara, y las meninges y vasos sanguíneos de la fosa anterior y media de la base del cráneo. El estímulo nociceptivo originado en esta área es recogido por una de las tres ramas del nervio trigémino (nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular) y transmitido a lo largo del ganglio trigeminal (o de Gasser) y de su raíz sensitiva hasta el núcleo espinal del trigémino. Es importante tener en cuenta que, debido a sus conexiones anatómicas, otros nervios craneales que participan en la sensibilidad de la cara, y los primeros nervios cervicales (principalmente por medio de los nervios occipitales), pueden producir dolor facial al influir en los mecanismos nociceptivos del nervio trigémino.

El dolor facial idiopático persistente es un término general que incluye varios síndromes dolorosos de la cara y de la boca, previamente denominados dolor facial atípico. Estos síndromes de dolor facial crónico se caracterizan por no poseer las características clásicas de las neuralgias craneales y por no tener criterios diagnósticos claros, además requieren que el examen neurológico sea normal.

Conceptualización del dolor facial

Las algias faciales cronificadas requieren un abordaje particular que incluye el tratamiento médico conservador y el tratamiento intervencionista. Característicamente, el tratamiento debe ser multidisciplinario.

El tratamiento conservador incluye la orientación y educación del paciente sobre su patología y la indicación de diversos fármacos de uso general o específicos según el caso. El tratamiento intervencionista incluye bloqueos, radiofrecuencia, neuroestimulación o cirugía. El abordaje intervencionista se plantea cuando no hay buena respuesta terapéutica al tratamiento conservador.

En cuanto a la fisiopatología de la neuralgia primaria del trigémino, se destaca la importancia de la sensibilización central por efecto nociceptivo crónico debido a la presencia de compresión del nervio trigémino (principalmente cerca de su origen a nivel del tronco del encéfalo) por vasos sanguíneos o por tumores. Por otra parte, procesos inflamatorios, como los implicados en la neuralgia postherpética o en la esclerosis múltiple, permiten plantear como mecanismos adicionales la lesión neuronal y/o los procesos de remodelación sináptica que pueden alterar el circuito de nocicepción a nivel facial y su modulación, en especial cuando el dolor se hace crónico.

La fisiopatología de las algias faciales atípicas es desconocida, en muchos de los casos no se puede determinar la causa. Como posible mecanismo se ha planteado la sensibilización central de las vías del dolor en relación con procesos como la osteonecrosis de cavidades faciales, las infecciones de los senos paranasales o dentarias, y con procesos odontogénicos como pulpitis y alveolitis.

Epidemiología

La neuralgia del trigémino representa una causa importante de deterioro de la calidad de vida en los pacientes que la padecen y es considerada la forma más común de dolor facial en mayores de 50 años. Se ha estimado que la incidencia anual se ubica en 4–5 casos nuevos por 100.000 pacientes, especialmente entre los 50 y 70 años (90 % de los casos comienzan en mayores de 40 años de edad), siendo más prevalente en mujeres.

Clasificación del dolor facial

Las algias faciales pueden clasificarse en primarias (si su causa es indeterminada y no está clara) o secundarias (si la causa responsable del dolor es conocida). En todo caso, el diagnóstico de las algias faciales, especialmente cuando se cronifican, requiere primero descartar las causas de dolor facial secundario (ej.: tumores, alteraciones vasculares, infección, inflamación, artrosis articulares de la cabeza y del cuello) mediante la anamnesis, el examen físico y las pruebas complementarias correspondientes especialmente aquellas del área neuroquirúrgica.

Aspectos clínicos del dolor facial

La neuralgia del trigémino se caracteriza por ser un dolor facial unilateral de carácter punzante, superficial y descrito como una descarga, de intensidad moderada a severa, que dura unos segundos a pocos minutos. Entre sus factores desencadenantes se encuentran el tacto ligero en zonas específicas de la cara (zonas gatillo), o actividades como comer, hablar o lavarse la cara, y entre sus factores atenuantes, el sueño. La frecuencia de afectación de las ramas es la siguiente: nervio maxilar y nervio mandibular (32 %), las tres ramas (17 %), solo el nervio maxilar (17 %), solo el nervio mandibular (15 %), nervio oftálmico y nervio maxilar (14 %) y solo el nervio oftálmico (4 %) *(figura 1)*.

El dolor facial idiopático es un diagnóstico de exclusión. Se pueden incluir dolor por desórdenes óseos del cráneo, cefalea cervicogénica, dolor orbitario, glaucoma agudo, anormalidades de refracción y estrabismo, neuritis óptica, síndrome del seno cavernoso, patologías dolorosas del oído, sinusitis, desórdenes de la mandíbula y de los dientes, síndrome de la articulación témporo-mandibular, neuralgia de los nervios craneales, neuralgia postherpética, cefaleas por compresión externa, anestesia dolorosa, dolor central posterior a accidentes cerebrovasculares, etc.

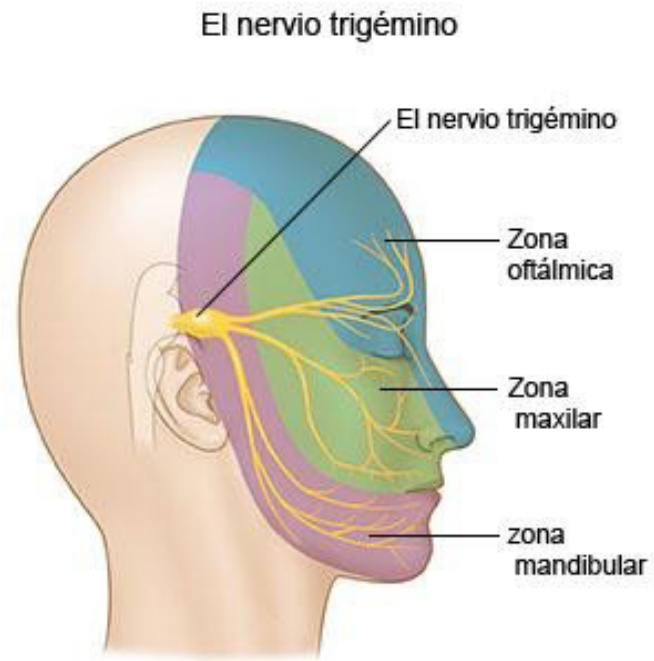

Figura 1. Neuralgia del trigémino.

Manejo diagnóstico. Pruebas complementarias

La Sociedad Internacional de Cefalea (IHS,International Headache Society) ha definido criterios diagnósticos para la neuralgia del trigémino *(tabla 1)*.

Tras la crisis suelen coexistir periodos libres de dolor que pueden durar semanas o meses. Es muy importante el diagnóstico diferencial con patologías que pueden ser la causa de la neuralgia. Hay que hacer hincapié en que el paciente con neuralgia primaria del trigémino debe poseer un examen neurológico sin otras anormalidades, y en todo caso se deben realizar los estudios complementarios específicos para descartar causas de dolor secundario (en especial resonancia magnética nuclear).

Para el dolor facial idiopático persistente, se han planteado los siguientes criterios diagnósticos *(tabla 2)*:

1. Ataques paroxísticos de dolor que duren desde un segundo a dos minutos, que afectan una o más divisiones del nervio trigémino y que cumplan completamente con los criterios 2 y 3.
2. Dolor con al menos una de las siguientes características:
   a. Intenso, punzante, superficial o terebrante.
   b. Precipitado por áreas gatillo o por factores desencadenantes.
3. Ataques estereotipados en el paciente individual.
4. No hay evidencia clínica de déficit neurológico.
5. No puede ser atribuido a otra causa.

Tabla 1.

1. Dolor facial presente diariamente, persistente a lo largo del día o en la mayor parte del mismo, y que cumple los criterios 2 y 3.
2. Dolor confinado en su inicio a un área limitada en un lado de la cara (posteriormente puede ser bilateral), de carácter profundo y pobremente localizado:
   a. Debajo de la línea del cuero cabelludo, arriba del cuello y en frente de las orejas.
   b. Comienza en los bordes nasolabiales o en los lados de la mandíbula y se extiende fuera de la mandíbula superior e inferior o hasta una gran parte de la cara o del cuello.
3. Dolor no asociado con pérdida sensorial u otros signos físicos.
4. Exámenes complementarios incluyendo rayos-X de la cara y mandíbulas no debe demostrar ninguna anormalidad.

Tabla 2.

Terapias combinadas en el manejo del dolor facial

El tratamiento de la neuralgia del trigémino se divide en médico conservador e invasivo e intervencionista.

El tratamiento conservador consiste en instaurar fármacos para dolor neuropático, preferiblemente la combinación de antiepilépticos, inhibidores de la recaptación de serotonina y/o catecolaminas, además de un analgésico según la intensidad del dolor. Entre estos fármacos, el de primera elección es la carbamazepina (400–800 mg/día) o la oxcarbazepina (900–1800 mg/día), otros fármacos utilizados son la fenitoína (300–500 mg/día), el baclofén (40–80 mg/día), el clonazepam (1,5–8 mg/día), el valproato (500–1500 mg/día), la lamotrigina (150–400 mg), y la gabapentina (900–2400 mg/día).

El tratamiento del dolor facial idiopático persistente es difícil y requiere un abordaje multidisciplinario. El tratamiento convencional debe incluir evaluación y orientación psicológica junto con la terapia farmacológica. En esta última es de elección primaria la amitriptilina (25-100 mg/día) combinada con antiepilépticos (pregabalina, gabapentina) y con inhibidores de la recaptación de serotonina como duloxetina o desvenlafaxina.

Abordaje invasivo en el tratamiento del dolor facial

El tratamiento intervencionista se plantea en caso de fallo terapéutico del tratamiento conservador e incluye la descompresión quirúrgica microvascular, la terapia de radiación estereotáxica que ha mostrado una reducción del dolor 60-70 %, la microcompresión percutánea con balón, la rizólisis percutánea, la radiofrecuencia percutánea del ganglio trigeminal (de Gasser) y la neuromodulación del ganglio de trigeminal. En pacientes jóvenes es de primera elección la descompresión microvascular (es frecuente el atrapamiento del nervio), mientras que en pacientes adultos mayores de 40-60 años, es de primera elección la radiofrecuencia del ganglio de Gasser. Este último procedimiento tiene baja morbilidad. Entre los efectos adversos se pueden encontrar la disminución del reflejo corneal (5.7 %), la debilidad y parálisis del músculo masetero (4.1 %), disestesia facial (1 %), anestesia dolorosa (0.8 %), queratitis (0.6 %) y parálisis temporal del 3er y 4to nervio craneal (0.8 %) *(figura 2)*.

Figura 2. Radiofrecuencia convencional de Ganglio de Gasser.

El tratamiento intervencionista, el dolor facial atípico, se plantea en el caso de fallo del tratamiento convencional e incluye como principales procedimientos la radiofrecuencia convencional del ganglio esfenopalatino y el tratamiento quirúrgico. La radiofrecuencia del ganglio esfenopalatino ha reportado alivio completo del dolor en un 21 % de los casos con buena a moderada mejoría en el 65 %, además de baja morbilidad (figura 3).

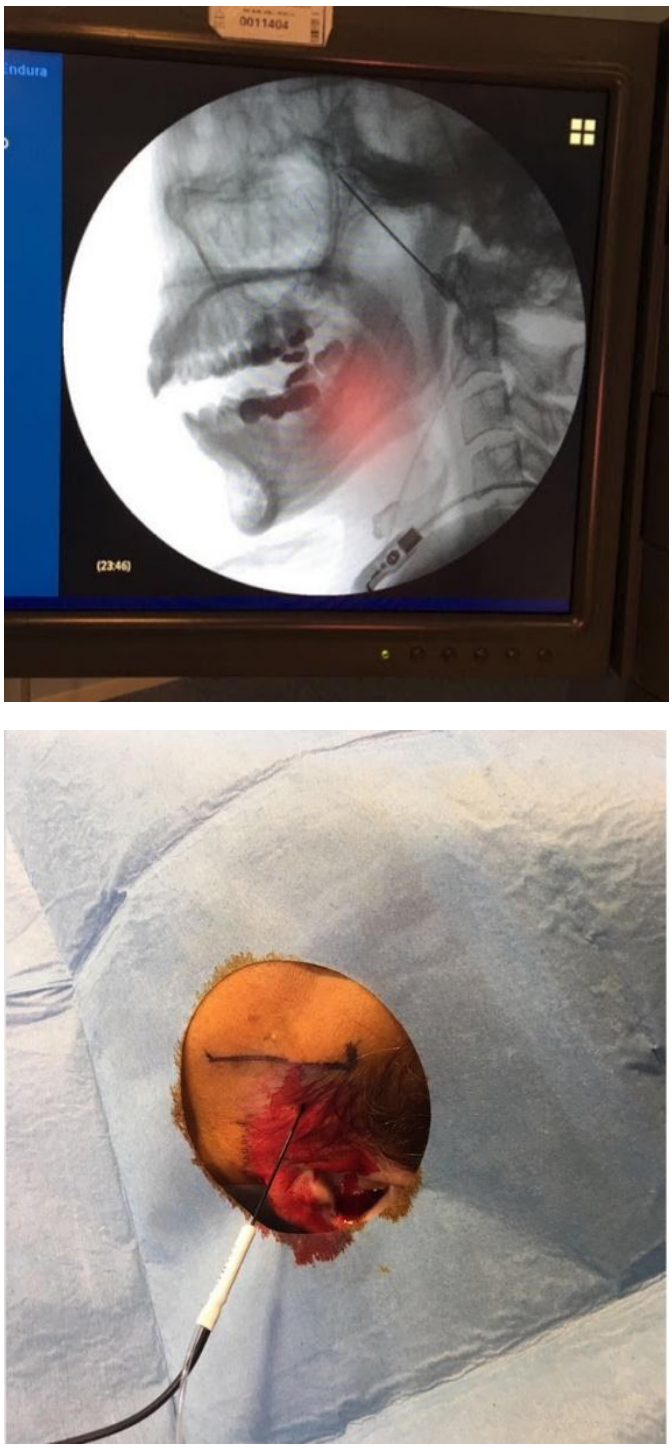

Figura 3. Radiofrecuencia convencional de ganglio esfenopalatino.

Bibliografía y fuentes de consulta

1. Van Suijlekom et al. Whiplash-Associated Disorders (EvidenceBased Interventional Pain Medicine according to Clinical Diagnoses). Pain Practice. 2010: Volume 10 (Issue 2):131–136.
2. Longstaff, A. BIOS Instant Notes in Neuroscience. New York: Garland Science; 2011.
3. Benzon H.T. et al. Essentials of pain medicine. Philadelphia: Saunders; 2011.
4. Biller J. et al. DeMyer's. The neurologic examination. A Programmed Text. New York: The McGraw-Hill Companies; 2011.
5. Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders. Oxford: Blackwell Publishing; 2005.
6. Vanelderen et al. Occipital Neuralgia Headache (Evidence-Based Interventional Pain Medicine according to Clinical Diagnoses). Pain Practice. 2010; 10, (2): 137–144.
7. Van zundert et al. Evidence-Based Interventional Pain Medicine According to Clinical Diagnosis. Pain Practice. 2011; 11, (5): 423–429.
8. Gary W. Jay. Clinician's guide to chronic headache and facial pain. New York: Informa Healthcare; 2010.
9. Van Suijlekom et al. Cervicogenic Headache (Evidence-based Interventional Pain Medicine according to Clinical Diagnoses). Pain Practice.2010; 10, (2): 124–130.
10. Maarten van Kleef et Al. Cluster Headache (Evidence-Based Interventional Pain Medicine according to Clinical Diagnoses). Pain Practice. 2009; 9, (6): 435–442.